

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL)

استخراج حصوات الكلية عن طريق فتحة في الجلد

1. What do I need to know about this procedure?

A cystoscopy (a telescopic instrument looking into the bladder) will be done first to put a catheter (tube) through the opening of the ureter (the tube which carries urine from the kidney to the bladder) and into the kidney. Contrast medium can then be injected along this tube into the kidney so that the kidney can be seen on x-ray during the procedure.

After being placed in a face down position, a needle is put into the loin to puncture the kidney, with the x-ray guiding the way. Once the kidney is punctured, the track is slowly widened. The kidney is then inspected with a telescope called a nephroscope. Small stones can then be removed. If the stone/s are too big, the stone/s will be shattered using mechanical energy such as a Lithocast or ultrasound. After the operation, a tube is passed into the kidney, exiting the body through the same wound.

JJ stent (ureteric stent) may be kept in the ureter after surgery up to 6 weeks

Foley catheter will be inserted and usually will be kept for 5-7 days

Two or three days after the operation and before the tube is removed, an x-ray may be taken by injecting contrast medium through the drain into the kidney. If there is no blockage, the tube will usually be removed.

2. My anesthetic

This procedure will require an anesthetic.

See **About Your Anesthetic information sheet** for information about the anesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

1. ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟

يتم أولاً إجراء تنظير للمثانة البولية باستخدام منظار المثانة البولية وهو من أدوات التقريب المستخدمة للنظر داخل المثانة البولية. يستخدم المنظار في وضع قسطرة (أنبوب) من خلال فتحة الحالب (الأنبوب الذي ينقل البول من الكلية إلى المثانة البولية) ، حيث تمرر هذه القسطرة إلى داخل الكلية. يمكن بعد ذلك حقن مادة الوسط المتباين إلى داخل الكلية عبر هذا الأنبوب مما يمكن من إظهار الكلية بالأشعة السينية خلال الإجراء.

بعد أن يستلقي المريض على بطنه، وبتوجيه من الأشعة السينية، يتم وضع إبرة في منطقة الخاصرة لإحداث ثقب في الكلية. عند إحداث ثقب الكلية، يتم ببطء توسيع المسار. يتم بعد ذلك فحص الكلية بأداة تقريب تسمى منظار الكلية. يمكن إزالة الحصوات الصغيرة. إذا كانت الحصوة الحصوات كبيرة، يتم تقطيع هذه الحصوات باستخدام طاقة ميكانيكية مثل تقنية ثقب الحصوات عبر مسبار الهواء المضغوط أو الموجات فوق الصوتية. بعد العملية، يمرر أنبوب إلى داخل الكلية ويتم إخراجها من الجسم عبر نفس الجرح. يمكن وضع دعامة (قسطرة حالب) في داخل الحالب التي قد تحتاج للبقاء حتى مدة 6 أسابيع. إبقاء قسطرة بولية لفترة تقريبية من 5 أيام إلى أسبوع.

بعد مرور يومين أو ثلاثة من الإجراء وقبل إزالة الأنبوب، قد يتم التقاط صور بالأشعة السينية بحقن مادة الوسط المتباين عبر أنبوب التصريف إلى داخل الكلية. إذا لم يكن هناك انسداد، فإنه تتم عادة إزالة الأنبوب.

2. التخدير الذي ألتقاه

سوف يتطلب هذا الإجراء تخدير. اقرأ ورقة معلومات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات، قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Bleeding, rarely risk of severe bleeding requiring open exploration of the kidney. If this occurs, the kidney may have to be removed.
- Infection, rarely Septicaemia (blood poisoning). Antibiotics are usually given to help prevent this.
- Very rarely, injury to the bowel. Further surgery and repair may be required.
- Injury to the pleura (lining of the lung cavity).

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبيير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين).
- قد يحدث انهيار (انطباع) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- نزيف نادر ما يحدث نزيف شديد يتطلب جراحة مفتوحة لاستكشاف الكلية. إن حدث ذلك ، فقد يكون من الضروري إزالة الكلية.
- التهابات. نادر ما يحدث تجرثم (تسمم) الدم. تعطى عادة المضادات الحيوية للمساعدة على تفادي حدوث ذلك.
- من النادر جداً حدوث إصابة للأمعاء . قد تكون هناك حاجة للإصلاح الجراحي.
- إصابة غشاء الجنب (الغشاء البلوري) وهو الغشاء المبطن لتجويف الرئة. قد يتطلب ذلك وضع أنبوب في الصدر لإعادة



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

This may require a tube to be put into the chest to re-inflate the lungs,

- During the procedure, a small fragment of stone may fall into the ureter causing a blockage. If this happens, a stent (a drainage tube between the kidney and the bladder) may be inserted.
- The aim of the procedure is to either clear the stone altogether or break up the stone. If breaking up of the stone is done, further surgery may be needed to remove other pieces of the stone from within the kidney.

Notes to talk to my doctor about:

نفخ الرئتين بالهواء.

- أثناء الإجراء ، قد تسقط أجزاء صغيرة من الحصوة إلى داخل الحالب مسببة انسداداً للحالب. عند حدوث ذلك ، فقد يتم إدخال دعامة (أنبوب تصريف بين الكلية والمثانة البولية).
- إن الهدف من الإجراء هو إما إزالة الحصوة بشكل كامل أو تفتيت هذه الحصوة. إذا تم تفتيت الحصوة ، فقد تكون هناك حاجة لجراحة أخرى لإزالة الأجزاء الأخرى من الحصوة من داخل الكلية.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
